当院の生理検査室における術中神経モニタリングの取り組みについて

◎小出 彩名[1)]、松岡 真生[1)]、大宮 琉奈[1)]、三田村 有梨[1)]、小路 達也[1)]、飯田 佳子[1)]、青木 美由紀[1)]、長屋 麻紀[1)]
地方独立行政法人 岐阜県総合医療センター[1)]

【はじめに】近年、医師の働き方改革としてタスク・シフト/シェアが推進され、これに伴い検査技師が実施可能な業務も拡大された。当院でも臨床工学部からの要望により、術中神経モニタリングを行うこととなった。その経緯と取り組み、今後の課題について報告する。【経緯】当院の術中神経モニタリングはこれまで医師が針電極の装着、臨床工学技士が針電極を除く電極の装着およびモニタリングを行っていた。法令改正によって検査技師が針電極を装着することが可能になったこともあり、業務を検査技師に引き継ぎたいと臨床工学部より要望があった。【取り組みと実績】当院で実施している術中神経モニタリングは脳神経外科と整形外科より依頼され、多くの術式を経験することが必要である。そのため、勉強会等で知識を得るとともに、臨床工学技士の指導のもと手術室での見学および研修を2名で開始した。また、検査室内での勉強会等で症例を共有し、様々な場面に対応できるようにしている。その後の検査技師教育では先に研修を開始した検査技師それぞれに付いて学び、現在は3名で実施している。検査技師のみでモニタリング業務が実施可能になった後、これまで医師が行っていた針電極の装着も医師の指導のもと開始した。2024年4月から2026年4月までの件数は、脳神経外科 MEP 16件、BCR 8件、AMR 1件、整形外科 MEP 16件、XLIF 8件の総件数49件であり、そのうち13件の手術で検査技師が針電極の装着に関わった。タスク・シフト/シェアにより他職種の業務軽減だけでなく、針電極の装着を検査技師が行うことで手技や波形の均質化が図られ、精度の安定化も期待できる。【今後の課題】現在3名でモニタリング業務を行なっているが、他の検査業務との兼ね合いや緊急手術で術中神経モニタリングが必要となった際に人員を確保するのが困難な場合も多くあるため、担当者の増員が必要である。また、タスク・シフト/シェア以降実施経験のない、もしくは少ないモニタリングもあるためより多く経験を積む必要がある。【結語】担当者を増やすとともに、知識と経験を積み重ね精度の高い術中神経モニタリングを実施できるようにしていきたい。

岐阜県総合医療センター生理検査室　058-246-1111(2653)